До прийому психіатра

Лада, 34 роки · 02.10.2026 · Короткий опис стану

Коротко про ситуацію

Останні два роки Лада майже постійно хворіє; останні місяці, особливо останній, стали важчими. Зараз найбільше турбують **тривога, поганий сон, біль, втома та дуже мале харчування**.

Тривога та її звичайний стан

Тривожність описує як давню, ще з дитинства. Водночас каже, що у спокійний день, коли все добре й нічого не потрібно робити, не дуже тривожиться. Є постійне відчуття, що треба щось робити. Описує **страх, що без постійних дій усе погіршиться або з нею станеться щось погане**. Пов’язує це з вимогами й залякуванням батьків у дитинстві. Навіть розповідаючи про цей страх, відчула фізичний дискомфорт у ділянці серця; точно описати відчуття їй важко.

Зараз боїться подальшого погіршення здоров’я, хвилюється через роботу й зобов’язання перед клієнтами. Має невеликий бізнес, зараз не працює. Описує епізоди тривоги, не обов’язково панічні атаки. **01.10 зранку тривога довго не минала без зрозумілої їй причини.**

Як змінювався стан

Згадує **один-два відносно щасливі місяці влітку**, коли здоров’я дало перепочинок. Приблизно в середині літа після сварки з матір’ю почалося поступове погіршення. Особливо важко стало в середині серпня під час іншої стресової ситуації. Найвираженіше погіршення триває приблизно шість тижнів.

Під час розмов їй складно описати свої емоційні відчуття та відокремити давні прояви від нещодавніх змін.

Сон, біль, апетит і втома

Давно погано спить; зараз важко заснути, сон переривчастий, рано прокидається. Бували погані сни, після яких не могла заснути. Під час спільних ночівель неодноразово прокидалася від болю й просила допомоги. Парацетамол допомагав мало.

Апетит давно поганий, а останнім часом **майже або зовсім відсутній**, їсть дуже мало. З дитинства болить живіт після їжі; часто їсть лише раз на день. Під час і після нападів астми описує поширений м’язовий біль, зокрема в ногах; періодично болить спина.

Бували періоди дуже сильної сонливості. Наприкінці вересня після їжі засинала на 1-2 години. Під час окремих епізодів сонливості були помітні сповільнена мова та нестійкість при ходьбі.

Здоров’я та ліки

Лада · 02.10.2026

Важливі фізичні проблеми

Багаторічна астма, сезонна алергія, щорічні госпіталізації через астму. За останній місяць були тяжкі реакції з набряком губ, язика або горла, викликами швидкої та адреналіном. Наприкінці серпня перенесла COVID. У березні була госпіталізація через кишкову непрохідність без операції. У 2024-2026 роках - кілька гінекологічних операцій, зокрема через розрив кісти з сильною кровотечею.

Є нестача заліза й порушення функції щитоподібної залози: **19.09 ТТГ 5,833 мкМО/мл, вільний Т4 0,54 нг/дл при нормі 0,61-1,47**. Зріст 170 см, вага 30.09 - 61 кг. Останніми тижнями були набряки та значні коливання ваги.

Попередній досвід лікування

Гінеколог радив Ладі уникати антидепресантів групи СІЗЗС. Раніше **Триттіко (тразодон) 50 мг перед сном** приймала лише чотири дні, потім припинила. **Гідазепам** близько місяця тому ніби допоміг на кілька днів; нещодавно знову спробувала, але каже, що тепер він посилює тривогу й втому та не допомагає.

Ліки у звичному прийомі

Ніксар (біластин) 20 мг зранку, за потреби до 40 мг на добу.

Увечері: **Дуспаталін Ретард 200 мг - 1 капсула; Проксіум 40 мг - 1 таблетка; Флебодіа 600 мг - 1 таблетка; Жастінда** (дієногест 2 мг + етинілестрадіол 0,03 мг); **Аваміс 27,5 мкг/розпилення** в ніс.

Інші призначення

Еутирокс 37,5 мкг перед сніданком. **Проксіум 40 мг** і **Дуспаталін Ретард 200 мг** призначені також зранку. **Симбікорт Турбухалер 160/4,5 мкг** - по одному вдиху двічі на день і додатково за потреби. Наведено призначені схеми; регулярність прийому цих препаратів не уточнена.

Нещодавно

Медрол припинила 28.09 після поступового зниження дози. До цього кілька тижнів були Медрол і неодноразово дексаметазон, зокрема під час невідкладної допомоги. Парацетамол давали через біль, із невеликим полегшенням.